

병동 낙상 예방 간호 가이드

이 문서는 신규 간호사의 교육과 RAG 검색 기능 점검을 위해 만든 가상의 학습 자료입니다.

학습 목표

낙상 위험요인을 구분하고, 입원 시 위험도를 평가하며, 환자별 예방 중재와 사고 후 보고 절차를 설명할 수 있다.

핵심 원칙

낙상 예방은 환경 정비만으로 끝나지 않는다. 위험도 평가, 환자·보호자 교육, 교대 간 인계, 상태 변화 시 재평가가 하나의 과정으로 연결되어야 한다.

가상 병동 기준

이 자료에서 고위험군 식별 표시는 청록색 삼각 스티커로 통일한다. 이 표시는 실제 의료기관 지침이 아니라 검색 테스트를 위한 가상 규칙이다.

확인 질문 : 고위험군을 나타내는 가상의 표식은 무엇인가?

언제 , 무엇을 평가할까요 ?

위험도 평가는 입원 직후뿐 아니라 환자의 상태와 치료 환경이 달라질 때 반복해야 합니다 .

평가 시점

입원 후 2 시간 이내에 최초 평가를 시행한다 . 이후 매일 오전 근무 시작 시 , 병실 이동 후 , 진정제 투여 후 , 수술 · 시술 후 보행을 재개할 때 다시 평가한다 .

주요 위험요인

최근 3 개월 이내 낙상 경험 , 보행 불안정 , 어지럼 , 인지 저하 , 시력 저하 , 잦은 배뇨 , 수면제 · 진정제 · 혈압강하제 사용 여부를 확인한다 .

기록 원칙

점수만 입력하지 말고 관찰된 위험요인과 필요한 도움 수준을 간호기록에 함께 남긴다 . 상태 변화로 재평가했다면 변화 원인도 기록한다 .

확인 질문 : 최초 낙상 위험도 평가는 입원 후 몇 시간 이내에 시행하는가 ?

위험 수준에 맞춘 행동

모든 환자에게 기본 중재를 적용하고 , 고위험 환자에게는 관찰과 이동 보조를 강화합니다 .

모든 환자

침상은 가장 낮은 위치에 두고 바퀴를 잠근다 . 호출벨과 자주 쓰는 물건은 손이 닿는 곳에 둔다 . 바닥의 물기와 이동 동선을 확인하고 미끄럼 방지 신발을 안내한다 .

고위험 환자

첫 보행 전 담당 간호사가 기립성 어지럼 여부를 확인한다 . 야간에는 2 시간 간격으로 필요를 확인하며 , 화장실 이동 시 반드시 직원에게 도움을 요청하도록 설명한다 .

교육 확인

환자에게 설명한 뒤 환자 자신의 말로 주의사항을 다시 말하게 하는 되말하기 방식으로 이해도를 확인한다 . 보호자가 있으면 동일한 내용을 함께 교육한다 .

확인 질문 : 야간 고위험 환자의 필요는 몇 시간 간격으로 확인하는가 ?

낙상 발생 시 대응 순서

환자를 바로 일으키기 전에 손상 가능성을 먼저 확인하고 , 평가 · 보고 · 재발 방지를 순서대로 수행합니다 .

즉시 조치

환자를 임의로 이동시키지 말고 의식 , 호흡 , 통증 , 출혈과 사지 변형을 확인한다 . 필요한 응급 도움을 요청하고 활력징후를 측정한다 .

보고와 관찰

담당 의사와 책임 간호사에게 즉시 알리고 기관 절차에 따라 사고 보고서를 작성한다 . 머리 충격이 의심되면 의식 수준과 신경학적 상태를 처방 및 병동 기준에 따라 관찰한다 .

재발 방지

사고 발생 후 30분 이내에 낙상 위험도를 재평가한다 . 발생 장소 , 시간 , 당시 활동 , 환경 요인을 팀과 공유하고 예방 계획을 수정한다 .

확인 질문 : 사고 후 위험도 재평가는 몇 분 이내에 시행하는가 ?